



Collection MedWIZ

4^e année médecine

NEUROLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

1. Neurologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Dystrophies musculaires progressives	10				
02	Maladie de Parkinson	14				
03	Ataxies	16				
04	Céphalées et migraines	18				
05	Myasthénie auto-immune et syndromes myasthéniques	20				
06	Algies faciales et névralgies	24				
07	Myopathies inflammatoires idiopathiques	26				
08	Neuropathies périphériques	30				
09	Encéphalites	32				
10	Sclérose en plaques	34				
11	Polyradiculoneuropathie aiguë - Syndrome de Guillain-Barré	36				
12	Coma	38				
13	Démences	42				
14	Sclérose latérale amyotrophique (SLA) - Maladie de Charcot	44				
15	Épilepsies	46				
16	Syndromes épileptiques	48				
17	États de mal épileptiques (EME)	50				
18	Accidents vasculaires cérébraux ischémiques transitoires (AIT)	52				
19	Accidents vasculaires cérébraux ischémiques constitués ou infarctus cérébraux	54				
20	Accidents vasculaires cérébraux hémorragiques - Hématome intraparenchymateux (HIP)	56				

2. Neurochirurgie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
21	Hypertension intracrânienne (HIC)	60				
22	Hydrocéphalie	62				
23	Tumeurs cérébrales	64				
24	Craniosténoses	66				
25	Compression médullaire lente (CML)	68				
26	Malformations occipito-vertébrales et vertébro-médullaires	70				
27	Traumatismes cranio-encéphaliques	72				
28	Hémorragies cérébro-méningées	74				
29	Tumeurs sous-tentorielles	76				
30	Tumeurs sus-tentorielles	78				
31	Infections et parasitoses du système nerveux central	80				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
32	Syndromes topographiques en neurologie	84				
33	Examen neurologique	86				
34	Syndromes pyramidaux et hémiplégie	88				
35	Syndrome cérébelleux	90				
36	Sensibilité (Somesthésie)	92				
37	Grands syndromes médullaires	94				
38	Imagerie en neurologie	96				
39	Prise en charge d'un AVC	98				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

Chapitre I

© 2026 The WIZ The WIZ All rights réservés.

Neurologie

© 2026 The WIZ - Tous droits réservés.

DYSTROPHIES MUSCULAIRES PROGRESSIVES (DMP) (1)

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Groupe de pathologies musculaires héréditaires rares, hétérogènes cliniquement et génétiquement
- Affectent les muscles ayant atteint leur maturité structurelle
- Caractéristiques communes : début dans l'enfance/adolescence, déficit proximal, amyotrophie, évolution progressive
- Atteinte possible d'autres organes : cardio-respiratoire, digestif, cérébral

II. CLASSIFICATION

- Avant génétique : basée sur clinique et mode de transmission (Batten 1909, Gherrardi 1989)
- Actuelle : basée sur physiopathologie cellulaire et identification du gène/protéines impliquées

III. ANATOMOPATHOLOGIE (PROCESSUS DYSTROPHIQUE)

- Irrégularité de taille des fibres
- Fibres nécrosées
- Fibres en régénération
- Fibro-adipose (fibrose et infiltration graisseuse)

IV. PRINCIPALES DYSTROPHIES

1. DYSTROPHINOPATHIES (DMD ET BMD)

	DMD (DUCHENNE)	BMD (BECKER)
Transmission	Gonosomique récessive liée à l'X (Xp21) - atteint les garçons	
Protéine	Dystrophine (427 KDa, 3685 AA, 79 exons), rôle dans la stabilisation du cytosquelette	
Début	3-4 ans (marche retardée, chutes, Gowers+)	Début moyen : 12 ans
Signes	• Hyperlordose • Marche dandinante • Hypertrophie des mollets	• Moins marqués • ROT conservés longtemps
Évolution	Perte de la marche vers 10-12 ans Décès vers 20 ans (respiratoire/cardiaque)	Évolution plus lente Perte de la marche : 14-18 ans
Atteintes associées	Cardiaque : cardiomyopathie dilatée Respiratoire Troubles mentaux (40%)	Cardiomyopathie possible QI limite normale

Diagnostic :

- CPK augmentées (20x normale)
- EMG : tracé myogène
- Biopsie : aspect dystrophique
- Immunohistochimie : dystrophine absente (DMD) ou anormale (BMD)
- Analyse génétique :
 - délétions (65%)
 - duplications (5%)
 - mutations ponctuelles (30%)

Traitement :

- Corticoïdes (0,7 mg/kg/j)
- Thérapie génique en essai

2. DYSTROPHIE D'EMERY-DREIFUSS

- Transmission : AD, AR ou liée à l'X
- Triade :
 1. rétractions précoces (coudes, triceps suraux, cou)
 2. faiblesse huméro-péronière
 3. cardiomyopathie

3. MYOPATHIES DES CEINTURES (LGMD)

- Hétérogènes cliniquement et génétiquement
- Transmission :
 - AD (type 1)
 - AR (type 2)
- Déficit progressif des 2 ceintures + déformations rachidiennes
- Nouvelle classification 2017-2018 : LGMD R ou D + numéro + protéine

Type	Transmission	Préfixe	Exemple
LGMD R (Récessif)	Autosomique récessive (type 2)	R	LGMD R1 (déficit en calpaïne-3)
LGMD D (Dominant)	Autosomique dominante (type 1)	D	LGMD D1 (lamine A/C)

- Protéines impliquées variées (sarcoglycanes, calpaïne-3, dysferline, FKRP, ...)
- Âge de début variable, évolution lente